



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : عصمت حمدي حسين عطا
المحافظة : بني سويف الحي / المدينة : ببا
رقم البطاقة : 26704202201283 رقم التليفون : 01000670026
العنوان : =
العمر (تاريخ الميلاد) : 20-04-1967 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 09-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: عصمت حمدي حسين عطا National ID: 26704202201283	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Name: عصمت حمدي حسين			
MR. : 3526			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	
بشأن تقرير طبي للمريض			
رقم طبي:		بقسم:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient underwent a wide local excision with sentinel lymph node dissection in 2021, pathology revealing a T2 N0 M0 breast carcinoma. In 2022 the patient received adjuvant chemotherapy consisting of three cycles of doxorubicin and cyclophosphamide (AC*3) followed by three cycles of docetaxel (TXT*3), and was initiated on HERCEPTIN and NOLVADEX in January 2022. A chest CT performed in April 2026 was reported as unremarkable, and a subsequent evaluation in June 2026 noted a thickened endometrium without measurable dimensions. A DEXA scan was also obtained and was free of significant findings. The patient was prescribed tamoxifen for a planned duration of three months.			
تحريرا في ,			
التاريخ :		20-09-2026	
الوقت :		نهى سعيد علي محمد	
الطبيب المعالج :			
يعتمد ,			

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION AND DECISION SUPPORT

الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار

جهة الاصدار: رئاسة الهيئة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن العشرى" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي

والبحث تبين ان

المسيد (5) عصمت حمدي حسين بطاقة رقم 26704202201283

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
باعتبار من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي
وشكرا

تحريرا في: 2021-2-23

الموظف المختص
شادي جعفر الاصداري

الهيئة العامة للتأمين الصحي
إدارة مركز نظم المعلومات
بغداد

مستل 13387

الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ودعم القرار



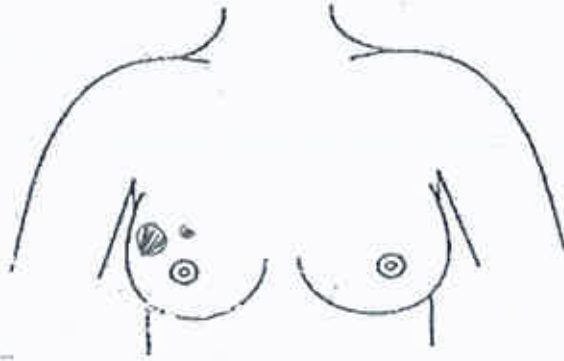
Name: Mr. Pund Cule
Age: 50 yrs
No.: _____

virtual
(6/2/2021)
01000670026

MDT FORM

Clinical data :

- Rt CT₁ N
- Triple +ve
- CT₁ → NAD



Reason of discussion: ⊕ Re MDT

For 3 - New SM (as available → 11/2020) → (Tomorrow)

⊕ Cl. exam., echog.

New SM 8 - Rt path. proven B6 Ax Tail men
NO LNS

MDT Outcome and Plan

Signature :

د. ل. ع. 8/1/2021
د. ل. ع. 8/1/2021



Pathology Report

Name: عصمت حمدي حسين عطا

Age: 50years.

Clinical data: Right breast cancer.

Specimen type: BCS and SLNs.

Date (Received): 4/3/2021

Date(reported): 14/3/2021

Lab. Number: 420/21

Hospital Number:/21

Gross Description:

Right BCS and SLNs 17x10x3cm tissue covered by skin ellipse 13x5cm. cut section revealed greyish white mass 3x2cm away from deep margins 2cm (5, 6, 7, 9) lateral, superior, medial and inferior surfaces respectively. A cyst away from lateral margin by 2cm, measure 3x2cm filled with watery fluid and has a thickened wall.

Microscopic Examination:

histopathological examination reveals an infiltrating malignant epithelial growth. The tumour is made up of groups and small sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate [grade II]. Focal intraduct component is detected (comedo type). Inconspicuous perineural invasion and lymphovascular emboli. Rest of breast tissue shows proliferating irregularly dilated ducts. The ducts are lined by inner columnar and outer myoepithelial cells, with focal epitheliosis. Surgical resections margins are free. Free SLNs(0/6).

Diagnosis:

- Invasive duct carcinoma grade II
- Focal ductal carcinoma in situ component (comedo type) +/- 10%.
- Inconspicuous perineural invasive and lymphovascular emboli.
- Rest of breast tissue: fibrocystic changes with focal epitheliosis
- Free resection margins
- Free SLNs (0/6)
- Stage p T2 , p N0, p Mx.

Prof. Dr. Lubna Omar.
Dr. Mona. Mohamed



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m7128

Female :	النوع	عصمت جمدى حنين عطا	اسم المريض
القاهرة :	العاون	53 Y	العنوان
28/12/2020 14:27 :	تاريخ استلام العينة		تاريخ أخذ العينة
12/01/2021 12:08 :	تاريخ التقرير	مركز اورام دار السلام	مكتب التحليل
		مركز اورام دار السلام	عينة

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER SPR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample received was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor(PR) (IE2)Rabbit monoclonal primary antibody.

Sample received was treated by: -VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.

Sample received was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: strong nuclear staining of > 60 % of tumour cells (CORE BIOPSY)

PR: strong nuclear staining of 60 % of tumour cells (CORE BIOPSY)

HER2/neu protein over expression: strong membrane staining of > 10 % of tumor cells (CORE BIOPSY)

Ki67: positive nuclear staining of about 20 % of tumour cells (CORE BIOPSY)

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 8/8)

PR: POSITIVE (SCORE 7/8)

HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION: POSITIVE (SCORE 3 +)

Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS ABOUT 20 %

Pathologist

د. نورا ماهر

Lab Director:

د. نورا ماهر

15 El-shaikh Rehan Street, Abdeldeen, Cairo
Tel: (065) 7948544 - 7950098 Fax: (202) 7948544
Mobile: 01144237292
website: <http://www.healthlabs.net>
e-mail: pathology@yahoo.com
facebook: [healthlabs](https://www.facebook.com/healthlabs)

يتم الاحتفاظ بالعينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها



Radiology Department

قسم الأشعة

Name: samir hamdy hassin

Date: 19 august 2021

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Enlarged in size (17cm at RT MCL) bright parenchymal echopattern with smooth surface.
- No hepatic focal lesions or intra hepatic biliary radicle dilatation.
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

- Average distention and capacity with no stones or mud
- The wall is not thickened.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average size , homogenous.

Kidneys: -

- Both are average in size, shape and echogenicity
- No stones or dilated pelvicalyceal system
- No gross lesion

Para-aortic and pancreatic area: show no gross abnormalities.

No ascites

Urinary Bladder: -

- Average capacity with no stones or diverticular out pouching

Uterus and adnexa: uterus is bulky, AVF, shows anterior wall intramural fibroid measures 25x20mm. endometrial thickness=9mm

Opinion:

Bright hepatomegaly likely fatty
Bulky uterus with fibroid and? endometrial thickening
Colonic gaseous distention

Best regards
Dr/nermeen Ramadan.MD



Patient Name: Esmat Hamdy Hussein Atta	Date : 01/12/2022
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 55 Year(s)
Medical ID: 5882/2020	Pat. ID: 24170

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had right CBS in 3/2020

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B) .
- right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with circumscribed round heterogenous operative bed lesion, seen at 11 o'clock 4cm from the nipple, measured 1.3x1.6cm.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with post-operative ?? fat necrosis, (BIRADS 3), for FU after 6 months
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

01/12/2022 2:20 PM



NUCLEAR MEDICINE UNIT

وحدة الطب النووي

Patient Name: Essmat Hamdy Husein.
Referring physician: Prof.

Date: 22/5/2021

^{99m}Tc -MDP BONE SCAN

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique: Anterior and posterior whole body scan performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Report:

- Warm uptake at mid lumbar vertebrae ?? marked degenerative for follow up.
- Degenerative changes at the dorsal and lumbar vertebrae.
- Arthritic changes at knees and shoulders.
- Otherwise the rest of surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion:

*No definite evidence of metastatic osseous deposits.
Follow up bone scan is advised.*

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit
Huda Fathy, M.D.
Magdy Kotb, M.D.



Patient name: Essmat Hamdey Hussien

Date: 7.2.2021

Combined bilateral breast mammography and complementary ultrasound

Indication:

Pathologically proven right breast cancer.

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B).
- Right UOQ (axillary tail) speculated high dense mass lesion harboring fine pleomorphic microcalcifications measuring 4.8x4.7cm with 10cm distance to the nipple (measures on CC view).
- Bilateral (more on the right side) scattered partially obscured rounded isodense mass lesions.
- Complementary ultrasound showed right 10 o'clock (axillary tail) speculated hypoechoic solid mass lesion with internal abnormal vascularity and calcifications is seen measuring 40x27.5mm with 2mm distance to the skin and more than 5cm distance from the nipple.
- Bilateral (more on the right breast) multiple scattered variable sized cysts, the largest on the right side is seen at 12 o'clock measuring 23.3x10mm, the largest on the left side at left retro areolar region measuring 9.3x7.3mm.
- Right 9 o'clock small complicated cysts is seen showing internal isoechoic contents measuring 11.3x7.3mm
- Bilateral mildly dilated retro areolar ducts reaching 5mm on each side.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex.
- Bilateral nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular regions.

Opinion:

- Right pathologically proven breast cancer showing 10 o'clock axillary tail malignant mass as described (BIRADS 6).
- Bilateral fibrocystic mammary changes and mild ductectasia (BIRADS 2).

Yours truly

Dr Mai Magdy